

## Púrpura de Schönlein-Henoch

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2021

Ateneo H. Notti 2014, AEP

Protocolos de Reumatología 2020

La púrpura de Schönlein-Henoch, o vasculitis por IgA, es una vasculitis de pequeños vasos (predominantemente capilares, vénulas y arteriolas) con depósito de complejos inmunes de IgA1 en la pared vascular que desencadenan una respuesta inflamatoria local que conduce a una vasculitis leucocitoclástica (depósito de leucocitos a predominio de neutrófilos), con necrosis de pequeños vasos sanguíneos.

Un alto porcentaje tiene un curso benigno, sin embargo debido al compromiso sistémico de algunos pacientes requiere un diagnóstico y seguimiento estricto.

Es la vasculitis predominantemente pediátrica (90% de los casos ocurren en la edad pediátrica), aunque se han descrito casos en adultos.

Es más frecuente entre las edades de 3 a 15 años, con un discreto predominio en el varón. La incidencia general se estima entre 10 y 20 casos/100 000 niños.

Se han observado importantes variaciones estacionales, con predominio de casos en los meses de invierno, siendo rara en verano.

### Etiología

Su patogenia no se conoce completamente, aunque se ha relacionado con la disfunción de los linfocitos T y ciertos polimorfismos genéticos. De esta manera, se le supone una predisposición genética individual sobre la que actúan factores ambientales.

Con frecuencia se encuentra el antecedente de afección del tracto respiratorio superior (30% a 50% de los casos):

- *Streptococo* Betahemolítico grupo A (30% de los casos)
- *Yersinia* o *Mycoplasma* (más raramente)
- Virus (EB, varicela, parvovirus B-19, etc.)
- Otros
  - Fármacos (penicilina, ampicilina, eritromicina, quinina)
  - Alimentos
  - Exposición al frío
  - Picaduras de insectos.

### Clínica

#### Manifestaciones cutáneas

El exantema palpable eritematoso violáceo de tipo urticarial aparece en el 75-100% de los casos.

- Simétrico.
- En miembros inferiores y nalgas preferentemente, puede afectar cara, tronco y extremidades superiores.
- Regresa en una o dos semanas. Suele reproducirse al iniciar la deambulación.
- La erupción puede ser pruriginosa pero rara vez es dolorosa.
- Pueden fusionarse y evolucionar hacia equimosis coalescentes, pudiendo convertirse en lesiones ampollosas o necróticas (raro en niños: 2%).
- Cuando desaparecen las lesiones hemorrágicas los depósitos de hemosiderina decolorarán la piel durante semanas.
- Al inicio del cuadro, sobre todo en niños pequeños (menores de 3 años), puede acompañarse de edema subcutáneo localizado que no suele dejar fovea en cuero cabelludo, cara, dorso de manos y pies, espalda, periné y escroto. de acompañarse.



### **Manifestaciones articulares**

Aparecen en el 50-80% de los niños.

Consiste en artritis o artralgiás que afecta a pocas articulaciones, predominantemente a grandes articulaciones de extremidades inferiores (rodillas y tobillos). Se pueden afectar articulaciones de los miembros superiores, incluyendo muñecas, codos y pequeñas articulaciones de los dedos.

Las artralgiás son transitorias y no migratorias, resolviéndose en pocos días o semanas sin dejar secuelas.

Puede preceder al rash y ser la primera manifestación en un 25% de los casos.

### **Manifestaciones gastrointestinales**

Se observan en el 50-75% de los niños.

Se producen por el edema y hemorragia submucosa e intramural secundaria a la vasculitis de la pared intestinal que afecta fundamentalmente al intestino delgado proximal.

La invaginación es la complicación gastrointestinal más frecuente, limitándose al intestino delgado (ileo-ileal) en el 60% de los casos, a diferencia de la invaginación idiopática que es típicamente ileocólica. La incidencia de esta complicación es muy variable, desde 0,4-3,5%.

La hemorragia intestinal masiva es rara (2%), no siendo infrecuente la presencia de sangre oculta en heces (56%).

### **Manifestaciones renales**

Las presentan un 20-55% de los pacientes, son las que marcan la gravedad o el peor pronóstico a largo plazo.

Son más frecuentes en niños mayores y adultos. Los síntomas renales generalmente aparecen en los primeros 2 meses tras la erupción cutánea. La afectación consiste en una glomerulonefritis (nefritis asociada a púrpura de Schönlein-Henoch [NPSH]). La mayoría de los casos de NPSH son leves y autolimitados. Los niños sin síntomas renales durante los primeros 6 meses presentan baja probabilidad de daño renal a largo plazo.

El hallazgo más común es la hematuria microscópica aislada que generalmente se desarrolla dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de la enfermedad.

El síntoma más común es la hematuria aislada, más raramente se asocia con proteinuria.

Si la afectación renal progresa, se produce un síndrome nefrítico con hematuria, hipertensión y oliguria.

También puede aparecer un síndrome nefrótico.

Por inmunofluorescencia se observan depósitos de IgA en el mesangio del glomérulo.

### **Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes**

#### **Manifestaciones neurológicas**

Cefaleas, cambios sutiles del comportamiento, hipertensión, hemorragias del SNC, y muy raramente neuropatías periféricas.

#### **Manifestaciones hematológicas**

Diátesis hemorrágica, trombocitosis, déficit de factor VIII, déficit de vitamina K e hipotrombinemia que podrían producir una coagulopatía.

#### **Manifestaciones pulmonares**

Neumonías intersticiales y, más graves, hemorragia pulmonar.

#### **Manifestaciones testiculares**

Dolor, inflamación o hematoma escrotal con riesgo de torsión testicular.

## Diagnóstico

Es clínico, tríada clásica: púrpura palpable no trombocitopénica, dolor abdominal y artritis.

## Diagnóstico diferencial

- Dolor abdominal: Invaginación u otro tipo de abdomen agudo quirúrgico.
- Artritis: Fiebre reumática, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide, LES.
- Exantema: Diátesis hemorrágica, reacción a fármacos, sepsis, meningococemia, malos tratos.
- Glomerulonefritis aguda.
- Testículo doloroso: Hernia incarcerada, orquitis o torsión testicular.

## Criterios clasificatorios EULAR/ PRINTO/ PReS para la VIgA/PSH

| Criterio                                        | Definición                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio obligatorio:<br>Púrpura                | Púrpura (frecuentemente palpable) o petequias, predominante en extremidades inferiores y no debida a trombocitopenia<br><br>En caso de púrpura con distribución atípica se requiere la demostración de depósito de IgA en una biopsia                            |
| <b>Al menos uno de los siguientes criterios</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Dolor abdominal                              | Dolor abdominal cólico difuso de inicio agudo reportado por anamnesis y exploración física. Puede acompañarse de invaginación o sangrado gastrointestinal                                                                                                        |
| 2. Histopatología                               | Típicamente vasculitis leucocitoclástica con depósito predominante de IgA o glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA                                                                                                                                  |
| 3. Artritis o artralgias                        | Artritis de inicio agudo definida como tumefacción articular o dolor articular con limitación de la movilidad o artralgia de inicio agudo definida como dolor articular sin tumefacción ni limitación de la movilidad                                            |
| 4. Afectación renal                             | Proteinuria >0,3 g/24 horas o cociente albumina/creatinina en orina >30 mmol/mg en muestra de orina matutina<br><br>Hematuria o cilindros de hematíes: >5 hematíes/campo de gran aumento o cilindros de glóbulos rojos en el sedimento o ≥2+ en la tira reactiva |
| Sensibilidad del 100%, especificidad del 87%    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **Exploraciones complementarias**

No hay ninguna prueba diagnóstica selectiva.

- Plaquetas: elevadas si hay inflamación, en general normales (si están disminuidas estamos ante otro tipo de púrpura: Trombocitopénica).
- TP, TTPK: normales
- Glóbulos blancos: puede haber moderada leucocitosis o eosinofilia
- Hto: anemia poco importante secundaria a sangrado.
- Urea y creatinina: elevadas en caso de fallo renal, aquí estaría indicada una biopsia renal.
- Orina completa: de forma sistemática para detectar compromiso renal, se puede observar hematuria y ocasionalmente proteinuria.
- Sangre oculta en materia fecal: con frecuencia es positiva.
- ECO abdominal: En casos de dolor abdominal intenso para descartar invaginación intestinal.
- Rx de tórax si sospechamos afectación pulmonar o TAC craneal si hay síntomas neurológicos.
- Hisopado de fauces o dosaje de antistreptolisina-O: en presencia de faringitis
- Toma de TA

## **Tratamiento**

- Antinflamatorios no esteroideos (AINE): no existe evidencia científica de que aumenten el riesgo de hemorragia digestiva con su uso en esta entidad.  
Están contraindicados en caso de hemorragia digestiva activa o afectación de la función renal, pero pueden indicarse en presencia de hematuria microscópica como único hallazgo, ya que esta es benigna.
- Corticoides: su uso es controvertido. Disminuyen la duración e intensidad del dolor articular, dolor abdominal, el riesgo de invaginación y el riesgo de intervención quirúrgica, por su efecto antiinflamatorio, pero no previenen la afectación renal ni las recurrencias, ni tampoco alteran la fisiopatología de la enfermedad.  
En las recientes recomendaciones SHARE se propone el uso de corticoides en:
  - Orquitis
  - Vasculitis cerebral
  - Hemorragia pulmonar
  - Afectación gastrointestinal grave
  - También estarían recomendados junto a otros inmunosupresores en otras manifestaciones graves o con compromiso vital.

Dosis: 1 a 2 mg/kg/día, en casos graves se pueden considerar pulsos endovenosos de metilprednisolona (10-30 mg/kg con un máximo de 1 g/día en tres días consecutivos).

## **Tratamiento Afectación cutánea**

El reposo disminuye la aparición de nuevas lesiones cutáneas, no precisando, en general, tratamiento específico añadido. En caso de lesiones bullosas, existen notificaciones del éxito del tratamiento con corticoides. Se han utilizado también agentes ahorradores de corticoides, como la dapsona y la colchicina.

## **Afectación articular**

Normalmente responden a tratamiento con AINES aunque existen datos sobre la rápida respuesta y el acortamiento de la duración de los síntomas con el uso de corticoides.

## **Enfermedad gastrointestinal**

El uso de prednisolona a 1-2 mg/kg (máximo, 60 mg) se podría considerar en niños con PSH y dolor abdominal moderado-severo, una vez descartada patología abdominal significativa, como la invaginación. En caso de vasculitis gastrointestinal muy severa

(enteropatía pierde-proteínas y la hemorragia gastrointestinal severa, entre otras), se ha descrito el éxito del tratamiento con infusión de gammaglobulinas, pulsos de metilprednisolona y plasmaféresis.

El dolor abdominal persistente o crónico es poco común, pero parece responder a metotrexate o micofenolato mofetilo, aunque deben ser valorados sus efectos secundarios gastrointestinales.

### **Tratamiento de las manifestaciones renales**

Su manejo sigue siendo controvertido. En las nuevas recomendaciones de la iniciativa SHARE se hace especial mención al tratamiento y manejo:

Como recomendación general debe considerarse el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) para prevenir o limitar la lesión glomerular secundaria en niños con compromiso renal con proteinuria persistente (>3 meses de duración) independientemente de si están recibiendo prednisolona u otro tratamiento inmunosupresor.

- En la NPSH leve (definida por TEFG normal y proteinuria moderada-leve) el tratamiento de primera línea es prednisolona oral.  
Se pueden usar azatioprina (AZA), micofenolato mofetilo (MMF) o metilprednisolona en pulsos endovenosos como tratamiento de segunda línea en pacientes con NPSH después de realizar una biopsia renal y de acuerdo con los hallazgos histopatológicos.
- En la NPSH moderada (definida por <50% semilunas en la biopsia renal y deterioro TEFG o proteinuria persistente grave) el tratamiento de primera línea es prednisolona oral o metilprednisolona en pulsos endovenosos. AZA, MMF o ciclofosfamida (CYC) por vía endovenosa se pueden usar en el tratamiento de primera o segunda línea de la NPSH moderada.

### **Pronóstico**

Generalmente una enfermedad autolimitada que se resuelve en 2-6 semanas, aunque hasta el 33% de los pacientes pueden presentar recurrencias. Las recurrencias parecen ser más probables entre los niños que presentan afectación renal, mientras que los pacientes de menor edad generalmente tienen un curso más corto y con menos recurrencias.

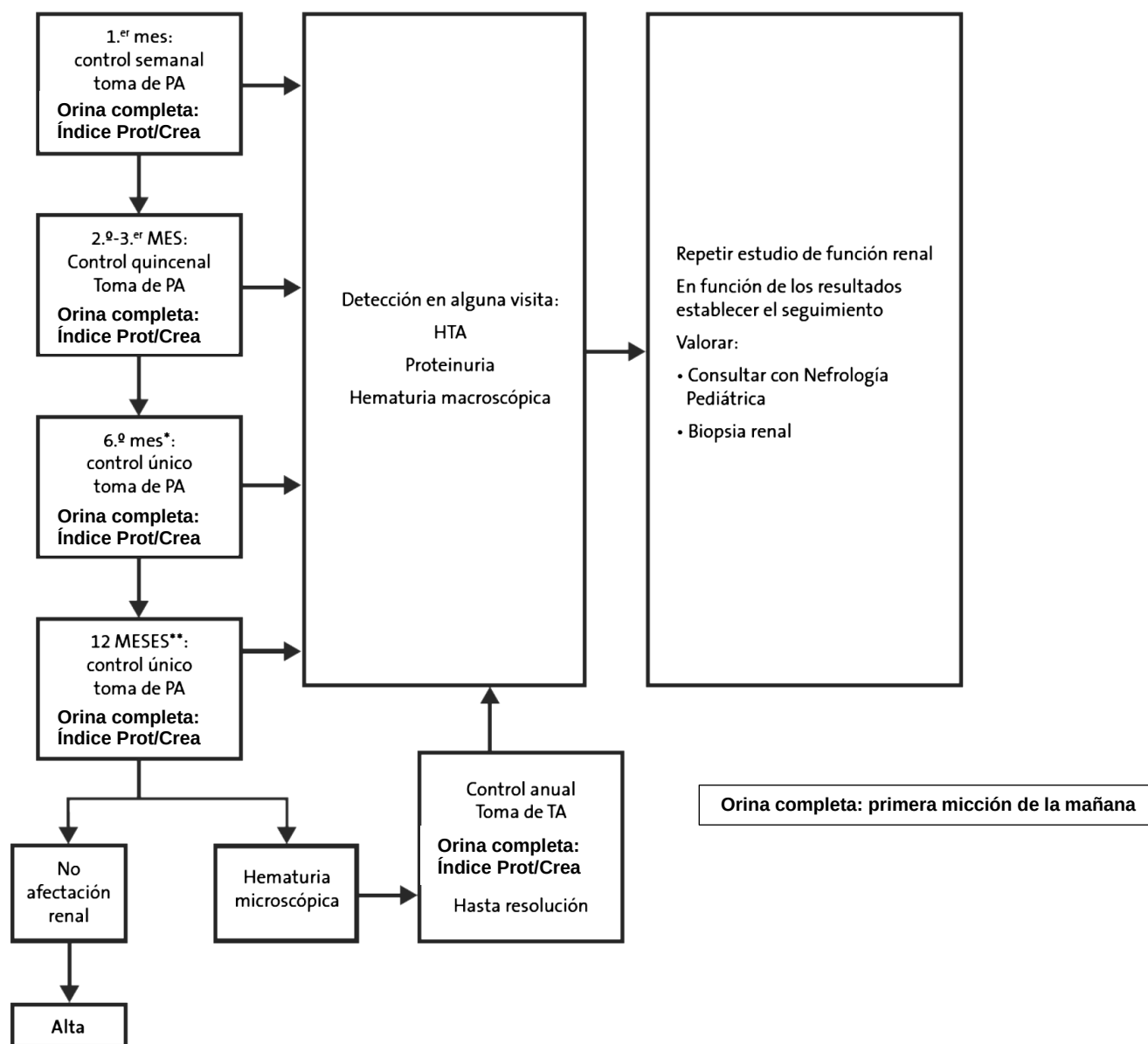
Los brotes suelen acontecer dentro de los 4 meses posteriores a la resolución de los síntomas iniciales, aunque se describen recaídas que sobrepasan los 18 meses del inicio de la enfermedad. Los síntomas y signos en las recurrencias tienden a imitar el episodio original, aunque suelen ser cada vez más leves y de menor duración, apareciendo de forma espontánea o bien en relación a infecciones respiratorias de vías altas. La recurrencia no predice una peor evolución a largo plazo.

La morbilidad en la fase inicial se debe principalmente a complicaciones gastrointestinales graves (invaginación y menos comúnmente perforación intestinal), mientras que el principal factor pronóstico en esta enfermedad a largo plazo viene determinado por la afectación renal.

El pronóstico renal es excelente cuando la hematuria o proteinuria se resuelven espontáneamente en pocos meses, correspondiendo generalmente a una afectación glomerular focal. El resultado a corto plazo de la enfermedad renal en VlgA/ PSH es favorable en la mayoría de los pacientes, con una recuperación completa en el 94 y 89% de los niños y adultos, respectivamente. El riesgo de afectación renal en forma de hipertensión, proteinuria o disminución del filtrado glomerular es del 2 al 15% según los estudios. El riesgo de insuficiencia renal terminal es <1%.

## Seguimiento

Una revisión sistemática de 12 estudios con 1133 niños con VIgA/PSH mostró que la afectación renal se producirá durante las primeras 4 semanas de la enfermedad en el 84% de los pacientes, durante las primeras 6 semanas en el 91% y en los primeros 6 meses en el 97%, por lo que se aconseja realizar un seguimiento mediante TA y sistemático de orina durante, al menos, los seis primeros meses desde el inicio de la enfermedad.



Si todas las determinaciones son normales el paciente no requiere seguimiento más allá de los 6-12 meses. Si presentaran alguna alteración deberá realizarse el seguimiento apropiado hasta la resolución de las alteraciones. Aquellos pacientes con un síndrome nefrótico o nefrítico deberán ser evaluados por un nefrólogo pediátrico.

En los pacientes con afectación renal leve se recomienda un seguimiento a largo plazo anual para descartar la posibilidad de progresión de la afectación renal.

En caso de episodios de VIgA/PSH recidivante, se recomienda efectuar el seguimiento como en el primer episodio.

## Propuesta de algoritmo para el manejo de la nefritis asociada a IgAV/PSH (NPSH)

